iCoach.Me
MAGAZIN

02
Ausgabe · November 2026
Wissen aus der Masterclass

LIFESPAN OS
POWER TO THE PEOPLE

Stark durch den Winter.

Aufwärmen, Cortisol, Vitamin D und Infekte – was wirklich schützt und was nur gut klingt.

−68 %
Verletzungsrisiko durch Krafttraining – Dehnen: −4 %

20 ng/ml
Vitamin D reicht laut DGE – nicht 60–90

−33 %
kürzere Erkältung mit Zink-Lutschtabletten

AUFWÄRMEN · CORTISOL · VITAMIN D · INFEKT & HERZ + Mythos-Check

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Gesund bleiben ist kein Zufall.

Die dunkle Jahreszeit bringt eigene Fragen mit: Brauche ich jetzt Vitamin D – und wie viel? Darf ich mit Schnupfen trainieren? Und hilft das Zink-Vitamin-C-Paket aus der Drogerie wirklich?

Ausgabe 02 beantwortet sie, wie immer auf Grundlage der *iCoach.Me Masterclass*. Wir starten im Gym: Warum das beste Aufwärmen die Übung selbst ist und Krafttraining dich besser vor Verletzungen schützt als Dehnen.

Dann geht es um Cortisol – das Hormon, das zu Unrecht als Muskelfeind gilt und ohne das du nicht leben könntest. Und um die „Nebennierenschwäche", die es gar nicht gibt.

Im zweiten Teil wird es winterlich: Vitamin D ohne Überdosis, richtiges Verhalten bei Infekt, das Herzrisiko beim Training mit Fieber und ein ehrlicher Blick auf Supplemente bei Erkältung.

Bleib gesund – und bleib dran.

Dein iCoach.Me Team

DIE WICHTIGSTE REGEL DIESER AUSGABE

Fieber bedeutet Trainingsverbot – ohne Ausnahme. Warum, liest du ab Seite 13.

INHALT

03 TRAINING
Aufwärmen, Mobility und Dehnen

05 MUSKELAUFBAU
Cortisol: Feind nur, wenn er chronisch ist

06 SUPPLEMENT-CHECK
Was senkt Cortisol wirklich?

07 HORMONE
Cortisol: Stresshormon und Lebensretter

08 SUPPLEMENTS
Vitamin D und K2: ausgleichen, nicht überdosieren

10 INFOGRAFIK
Die Vitamin-D-Skala

11 IMMUNSYSTEM
Richtig krank sein

13 IMMUNSYSTEM
Sport, Infekt und Herz

15 IMMUNSYSTEM
Supplemente bei Infekt

17 INFOGRAFIK
Die Trainings-Ampel bei Infekt

18 EXTRA
Mythos-Check: 8 Behauptungen

19 EXTRA
Zahlen der Ausgabe & Checkliste

20 SERVICE
Quellen, Impressum & Vorschau

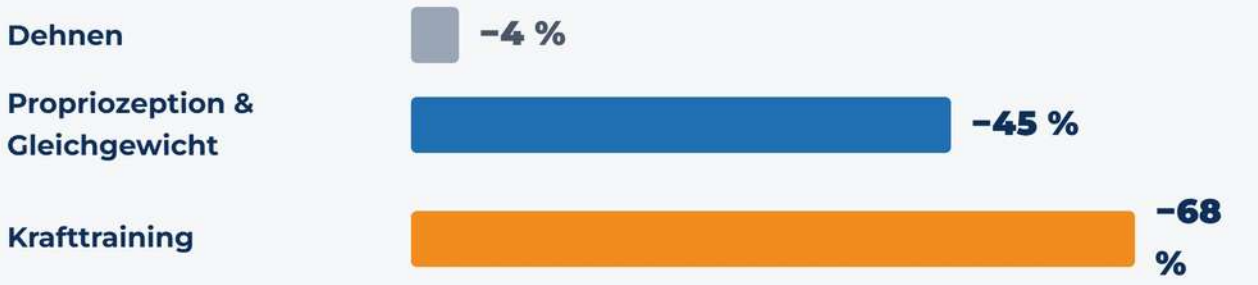
AUFWÄRMEN, MOBILITY & DEHNEN

Das beste Aufwärmen ist die Übung selbst

Lange Dehnroutinen, Mobility-Bänder, zehn Minuten Laufband: Was davon bringt dich wirklich weiter – und was schützt dich vor Verletzungen?

WIE STARK SENKT ES DAS SPORTVERLETZUNGSRISIKO?

25 randomisierte Studien, über 26.000 Personen



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Am besten belegt ist das **spezifische Aufwärmen**: die erste Übung mit steigender Last. Kurzes Dehnen unter 60 Sekunden pro Muskel kostet nur etwa 1 % Kraft – nicht gefährlich, aber auch nicht nötig. Dehnen verhindert keine Verletzungen, Krafttraining senkt das Risiko um rund zwei Drittel. Und Krafttraining über den vollen Bewegungsumfang macht genauso beweglich wie Dehnen.

Allgemein oder spezifisch?

Fünf Minuten auf dem Rad erhöhen die Körpertemperatur und schaden nicht – ob das zusätzlich nötig ist, ist weniger klar. Bei moderaten Gewichten bringt langes Aufwärmen kaum Vorteile; vor schweren Sätzen bleibt es sinnvoll.

Dehnen kostet Kraft?

Es kommt auf die Dauer an: unter 60 Sekunden pro Muskel etwa −1 %, ab 60 Sekunden etwa −4,6 %. Dynamisches Dehnen steigert die Kraft sogar um etwa 1 %. Die sportliche Gesamtleistung leidet unter statischem Dehnen nicht.

DEIN AUFWÄRM-PROTOKOLL

Vor der ersten schweren Übung



3–5 min	50 % × 8	70 % × 4	85 % × 1–2
allgemein, optional	1. Aufwärmsatz	2. Aufwärmsatz	3. Aufwärmsatz

Prozent deines Arbeitsgewichts. Für weitere Übungen, die dasselbe Gelenk beanspruchen, reichen 0–1 Aufwärmsätze.

Mobility-Drills und Bänder

Für bandgeführte Gelenkdistraktion bei Gesunden gibt es keine kontrollierten Studien; „Flossing“ zeigt kleine, kurzfristige Effekte. Mobility-Übungen sind ein legitimes Werkzeug, wenn sie sich gut anfühlen – eine belegte Prävention sind sie nicht.

Was die Forschung sagt

Bestätigt: Aufwärmen ist wichtig – der spezifische Teil am besten belegt.

Differenzierter: „Dehnen kostet Kraft“ – unter 60 Sekunden nur etwa 1 %.

Unbelegt: Dehnen vorher erhöhe das Verletzungsrisiko – kein Effekt, in keine Richtung.

Unbelegt: Mobility senke das Verletzungsrisiko.

So setzt du es um

1. Dehnen vorher nur bei Bedarf und kurz (unter 30–60 Sekunden pro Muskel), danach spezifisch aufwärmen.
2. Lange statische Dehnungen ab 60 Sekunden nicht direkt vor Maximalkraftsätze.
3. Beweglichkeit: zuerst voller Bewegungsumfang im Training. Mit konkretem Ziel zusätzlich 3–5× pro Woche mehrere Minuten pro Muskel dehnen.
4. Verletzungsprävention: Kraft- und Gleichgewichtstraining statt Dehnen.

Schmerzen ernst nehmen: Was über normales Ziehen hinausgeht oder anhält, ärztlich bzw. physiotherapeutisch abklären lassen.

MERKE

Krafttraining senkt das Sportverletzungsrisiko um gut zwei Drittel, Dehnen praktisch gar nicht. Krafttraining macht so beweglich wie Dehnen – das beste Aufwärmen ist die[illegible]g selbst mit steigender Last.

HORMONE & MUSKEL

Cortisol: Feind nur, wenn er chronisch ist

Der Cortisol-Anstieg im Training ist harmlos. Gefährlich für deine Muskeln ist das Cortisol, das dauerhaft hoch bleibt – durch Medikamente, Dauerstress und vor allem Schlafmangel.

AKUT – IM TRAINING

Normale Stressreaktion

In einer Studie mit 56 Männern ging der Cortisolanstieg im Training sogar mit etwas mehr Muskel- und Faserwachstum einher.

CHRONISCH – DAUERHAFT HOCH

Katabol

Baut Muskulatur ab und steigert Myostatin. Hoch dosiertes Kortison über längere Zeit schwächt vor allem Oberschenkel und Hüfte.

EINE DURCHWACHTE NACHT BEDEUTET …

−18 %	+21 %	−24 %
Muskelproteinsynthese	Cortisol	Testosteron

Nicht blockieren wollen

Cortisol ist lebenswichtig – ein Mangel kann lebensbedrohlich sein. Es geht nie darum, es auszuschalten, sondern dauerhaft erhöhte Spiegel zu vermeiden.

So setzt du es um

7–9 Stunden Schlaf zu festen Zeiten. Trainingsstress dosieren: Deload-Wochen einplanen, nicht dauerhaft am Limit. Gegen Stress: Spaziergänge, Atemübungen, soziale Kontakte.

MERKE Vor dem Cortisol im Training musst du keine Angst haben. Der stärkste Hebel gegen ungünstige Werte ist Schlaf – nicht ein Supplement.

Was senkt Cortisol wirklich?

Zahlreiche Präparate versprechen es. Die Studienlage ist sehr unterschiedlich – und oft fehlen die Sicherheitshinweise.

Supplement	Befund	Evidenz
Ashwagandha	Meta-Analysen etwa −10 bis −20 %, Einzelstudien −23 bis −28 %; fast alle herstellerfinanziert, höchstens 12 Wochen	moderat
Rhodiola	weniger Erschöpfung bei Burnout; in Sportstudien kein Cortisoleffekt	gemischt
Phosphatidylserin	dämpfte den Anstieg nach Belastung – in Studien mit 9–10 Personen	schwach
Magnolia/Phellodendron	Speichel-Cortisol −18 % in einer herstellerfinanzierten Studie	schwach
Omega-3	dämpft die Reaktion auf mentalen Stress, senkt nicht den Grundspiegel	teilweise
Magnesium	die oft zitierte Quelle ist eine Mausstudie – nur Mangel ausgleichen	nur Tier
Ginseng	keine belastbaren Humandaten gefunden	keine

ASHWAGANDHA: NUR NACH SORGFÄLTIGER ABWÄGUNG

Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät wegen möglicher Leberschäden zur Zurückhaltung; Dänemark hat Ashwagandha in Nahrungsergänzungsmitteln verboten.

Verzichten bei Lebererkrankungen, in Schwangerschaft und Stillzeit, bei Schilddrüsenerkrankungen und bei Medikamenten etwa gegen Blutzucker, Blutdruck oder Immunsuppressiva. **Sofort absetzen** bei dunklem Urin, Gelbfärbung der Haut oder Oberbauchschmerzen.

MERKE Ashwagandha senkt Cortisol in Meta-Analysen um etwa 10–20 % – mit Sicherheitsfragen. Schlaf, Spaziergänge und Atemübungen wirken ohne Nebenwirkungen und kosten nichts.

NEBENNIERE

Cortisol: Stresshormon und Lebensretter

Cortisol mobilisiert Energie, hält den Blutdruck stabil und bremst Entzündungen. Drei Punkte solltest du kennen.

1 **„Nebennierenschwäche“ gibt es nicht**

„Adrenal Fatigue“ ist keine anerkannte Diagnose – eine systematische Übersicht kommt genau zu diesem Schluss. Speichel-Cortisoltests aus dem Internet sind dafür ungeeignet. Gefährlich wird es, wenn deshalb Cortison „auf Verdacht“ genommen wird.

2 **Cortison nie abrupt absetzen**

Die Therapie ist lebensrettend – bei Asthma, Rheuma, Autoimmunerkrankungen, nach Transplantationen. Nach längerer Einnahme droht beim plötzlichen Absetzen eine lebensbedrohliche Nebenniereninsuffizienz. Reduzieren nur nach ärztlichem Plan.

3 **Morbus Addison: Krisen trotz Therapie**

Etwa einer von 10.000 Menschen ist betroffen. Auch unter Behandlung treten 6–8 Krisen pro 100 Patientenjahre auf – Notfallausweis und Notfallset sind Pflicht, bei Fieber oder Erbrechen wird die Dosis nach Schulungsplan angepasst.

Was den Alltag prägt

Cortisol steigt 30–45 Minuten nach dem Aufwachen an und fällt über den Tag ab – Messungen brauchen deshalb eine exakte Uhrzeit. Schlafentzug erhöhte das Abendcortisol um 37 % (teilweise) bis 45 % (vollständig).

So setzt du es um

Schlaf priorisieren. Stress aktiv regulieren – Bewegung, Pausen, Atem- oder Achtsamkeitsübungen; Meditation wirkt vor allem bei belasteten Menschen. Keine Internet-Speicheltests und keine „Nebennieren-Supplemente“ mit Hormonzusätzen.

MERKE Die „Nebennierenschwäche“ existiert nicht. Bei Morbus Addison treten trotz Therapie 6–8 Krisen pro 100 Patientenjahre auf. Schlafmangel erhöht das Abendcortisol um bis zu 45 %.

WINTERTIPP MIT GRENZEN

Vitamin D: ausgleichen, nicht überdosieren

Dass du im Winter ergänzen solltest, stimmt. Bei den Zahlen geht die Fitnessszene aber oft deutlich zu weit – und K2 ist kein Muss.



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die DGE hält einen Blutwert ab **20 ng/ml** für ausreichend; „optimale" 60–90 ng/ml stützt keine Evidenz. Die oft empfohlenen 5.000 IE liegen über der EFSA-Höchstmenge von 4.000 IE. Viele behauptete Wirkungen halten großen Studien nicht stand – ein kleiner Infektschutz zeigte sich nur mit täglichen niedrigen Dosen. Für K2 gibt es keinen belegten Nutzen aus randomisierten Studien.

Was die Institutionen sagen

DGE	800 IE (20 µg) täglich bei fehlender Eigenbildung; Blutwert ≥ 20 ng/ml (50 nmol/l)
BfR	höchstens 800 IE pro Tagesdosis in Nahrungsergänzungsmitteln; Vergiftungsfälle ab 10.000 IE
EFSA	Höchstmenge aus allen Quellen: 4.000 IE (100 µg) pro Tag
Endocrine Society 2024	keine Routinetests, kein belegter Zielwert; Gesunde unter 75: keine Dosen über der Referenzzufuhr

Versprochen – und gemessen

Bereich	Oft behauptet	Was große Studien zeigen
Knochendichte	+15–20 %	**+0,8 %**, nur am Schenkelhals (23 Studien)
Testosteron	+10–15 %	**kein Effekt** in einer randomisierten Studie
Depression	weniger Symptome	**kein Effekt** bei 18.353 Personen über 5 Jahre
Herz & Krebs	Schutz	**kein Effekt** (VITAL-Studie)
Atemwegsinfekte	starker Schutz	**klein**: OR 0,92 – deutlicher (OR 0,70) nur mit täglich 400–1.000 IE, nicht mit Hochdosis-Boli

Und Vitamin K2?

Die Zahl „–35 % Arteriosklerose“ steht nicht in der dazu zitierten Rotterdam-Studie – dort war hohe K2-Zufuhr mit weniger Herztod verbunden, eine Beobachtung. In randomisierten Studien zeigte K2 keine Wirkung auf die Knochendichte und bremste die Verkalkung der Herzklappen nicht.

Zielwerte und Grenzen

„Optimal 60–90 ng/ml“ ist nicht belegt, eine „deutsche Referenz von 30–60 ng/ml“ ist falsch. Die oft genannte Toxizitätsschwelle über 150 ng/ml stammt von Holick – Probleme können schon früher auftreten.

So setzt du es um

1. **Sommer:** Arme und Gesicht 10–25 Minuten zur Mittagszeit in die Sonne, ohne Sonnenbrand.
2. **Oktober bis März:** 800–1.000 IE täglich sind für die meisten Erwachsenen sinnvoll und sicher – auch ohne Test.
3. **Verdacht auf Mangel:** Blutwert ärztlich bestimmen lassen, Behandlung nach ärztlicher Vorgabe.
4. **Grenzen:** dauerhaft nicht mehr als 4.000 IE, keine Wochen- oder Monats-Boli in Eigenregie. K2 ist kein Muss.

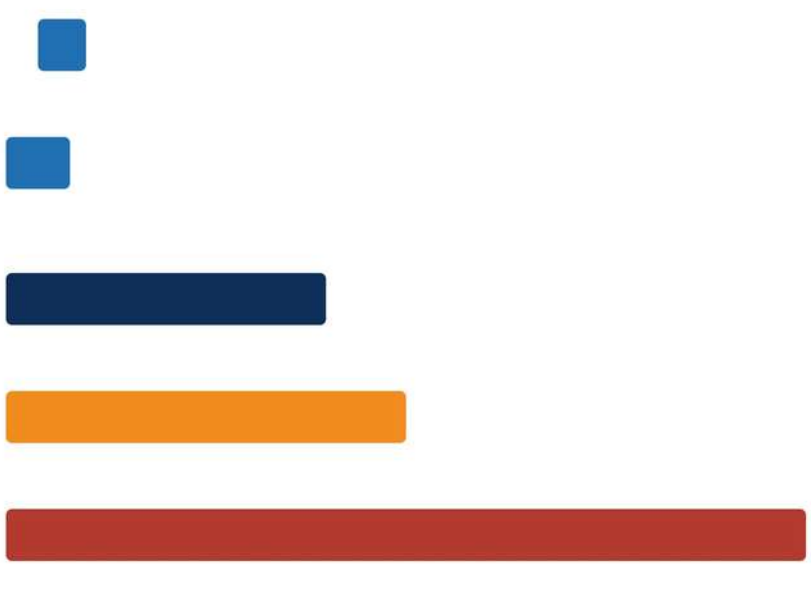
MERKE

Laut DGE reicht ein Wert ab 20 ng/ml. Die Knochendichte steigt um 0,8 %, nicht um 15–20 %. Infektschutz gibt es nur mit täglichen kleinen Dosen – die EFSA-Höchstmenge liegt bei 4.000 IE pro Tag.

Die Vitamin-D-Skala

Wo empfohlene Mengen liegen – und wo die Szene-Dosierungen landen.

TAGESDOSIS IN IE



1 µg = 40 IE · 800 IE = 20 µg · 4.000 IE = 100 µg. Balken maßstabsgetreu.

BLUTWERT 25-OH-D IN NG/ML



800–1.000 IE
täglich Oktober bis März

max. 4.000 IE
dauerhaft, aus allen Quellen

keine Boli
nicht in Eigenregie

VERHALTEN BEI INFEKT

Richtig krank sein

Die üblichen Regeln für den Krankheitsfall sind meist vernünftig – werden aber oft mit Scheinpräzision begründet. Der Faktencheck.

7–10 Tage
normaler Verlauf einer Erkältung

18 Tage
dauert Husten danach im Mittel

0 Studien
zu „mehr trinken“ bei Atemwegsinfekt (Cochrane)

Die Regeln im Faktencheck

Regel	Urteil	Was stimmt
Tag 1–3 strikte Bettruhe	unbelegt	Schonung bei Fieber ja; Bettruhe war nie besser als Aktivität
„Ohne Ruhe 14–21 Tage“	unbelegt	keine Datengrundlage – 7–10 Tage sind der natürliche Verlauf
1 Liter pro 20 kg trinken	falsch	nach Durst trinken, bei Fieber etwas mehr; zu viel kann den Natriumspiegel senken
„Toxine ausspülen“	falsch	kein physiologisches Konzept
Hühnersuppe „belegt“	nur Labor	Wirkung nur im Reagenzglas – als Mahlzeit trotzdem sinnvoll
8–10 h Schlaf	plausibel	Infekte erhöhen den Schlafbedarf
Kein Sport bis 100 % fit	teils	richtig bei Fieber und Allgemeinsymptomen; bei reinem Schnupfen strenger als nötig

SO VERLÄUFT EINE NORMALE ERKÄLTUNG

Tag 1–10
Erkältung: 7–10 Tage

bis Woche 3
Husten kann bleiben – im Mittel 18 Tage

Ein hartnäckiger Husten nach der Erkältung ist also normal – eine Verschlechterung nach anfänglicher Besserung nicht.

So setzt du es um

Zuhause bleiben
solange du Fieber hast oder dich krank fühlst – auch, um andere zu schützen.

Nach Durst trinken
bei Fieber etwas mehr; hellgelber Urin ist eine gute Orientierung. Warme Tees tun subjektiv gut.

Nach Appetit essen
Suppe, Brühe, leicht Verdauliches – liefert Flüssigkeit, Salz und Protein.

Schlaf hat Vorrang
Oberkörper leicht hochlagern, Raum lüften. Fieberfrei ist ein Spaziergang an der frischen Luft harmlos.

ÄRZTLICH ABKLÄREN LASSEN

- **Fieber länger als drei Tage**
- **Atemnot**
- **Brustschmerz**
- **Verschlechterung nach Besserung**

MERKE

Studien zu „mehr trinken bei Atemwegsinfekt“ gibt es laut Cochrane keine einzige. Normaler Husten nach einem Infekt dauert im Mittel 18 Tage. Bei leichter Erkältung ohne Fieber schadet moderates Training nicht.

SPORT, INFEKT & HERZ

Fieber heißt: kein Training.

Ein Virusinfekt kann den Herzmuskel mitbetreffen – und Belastung verschlimmert das nachweislich. Die wichtigste Regel dieser Ausgabe.

530×
mehr Virusvermehrung im Herzen bei Belastung (Mausversuch)

5 → 50 %
stieg dabei die Sterblichkeit der Mäuse

61 %
der Myokarditis-Todesfälle ohne vorherige Symptome (UK)

Auch beim Menschen gibt es klare Hinweise: Im deutschen Register ging fast allen jungen Sportlern, die an einer Herzmuskelentzündung starben, ein Atemwegsinfekt voraus.

Wie häufig ist Myokarditis als Ursache plötzlicher Herztode?

UK, Allgemeinbevölkerung (7.702 Fälle)	**1,1 %**
US-College-Athleten (NCAA)	**9 % der obduzierten Fälle**
Deutschland, sportassoziiert (n = 144)	**8 %; bis 35 J. rund 24 %**
US-Rekruten	**20 % der kardial erklärbaren**

Die „rund 25 %“ bei Sportlern bis 35 beruhen auf nur 37 Fällen. Saisonal: Im Januar lagen die Klinikaufnahmen wegen Myokarditis in Deutschland rund 30 % höher als im September.

Der Neck-Check

Nur Symptome oberhalb des Halses – Schnupfen, Halskratzen – und kein Fieber: leichte Aktivität ist möglich. Das ist eine Expertenregel **ohne Studienevidenz**. Sobald Fieber, Gliederschmerzen, Husten oder Abgeschlagenheit dazukommen: kein Training.

Zurück zum Sport

Nach dem Fieberende stufenweise steigern: erst zwei bis drei lockere Einheiten, dann wieder hart. Bei bestätigter Myokarditis gelten 3–6 Monate Pause; Wiedereinstieg erst nach kardiologischer Freigabe.

WARNZEICHEN – SOFORT STOPPEN UND ÄRZTLICH UNTERSUCHEN LASSEN

Brustschmerz	**Herzstolpern**	**ungewohnte Atemnot**	**Leistungsknick**

Abklärung etwa mit EKG, Herzultraschall (Echo) und Laborwerten.

Antibiotika und Training

Bei Erkältung, Grippe und meist auch bei Nebenhöhlenentzündung helfen Antibiotika nicht. Grundsätzlich gilt: Wer Antibiotika braucht, ist zu krank für Training. Und die Wirkstoffgruppe zählt:

Fluorchinolone
können Sehnenrisse und Aortenaneurysmen verursachen – bei leichten Infekten nicht einsetzen.

Makrolide
Unter Azithromycin war das Herztod-Risiko während der Einnahme 2,9-fach erhöht.

Penicilline
kein spezifisches Sportrisiko – entgegen dem verbreiteten „No-Go“.

So setzt du es um

Fieber bedeutet Trainingsverbot – ohne Ausnahme. Den Neck-Check nutzt du nur bei reinem Schnupfen, um dich locker zu bewegen; im Zweifel pausierst du. Unter Fluorchinolonen keine Sprung- und Sprintbelastungen; Sehnenschmerzen sofort ärztlich melden.

MERKE Nach bestätigter Myokarditis gelten laut Leitlinie 3–6 Monate Sportpause. Das „Fußballer-Phänomen“ geht häufiger auf angeborene Herzerkrankungen zurück als auf Myokarditis.

ERKÄLTUNGS-PROTOKOLLE IM CHECK

Supplemente bei Infekt: Was wirklich hilft

Zink, D, C, NAC, Glutamin, Curcumin, Omega-3 – hochdosiert ab dem ersten Kratzen? Am besten belegt ist nur eines davon. Und viele verbreitete Mengen liegen über den offiziellen Höchstmengen.

Mittel	Befund	Nutzen
Zink-Lutschtabletten	Erkältung rund 33 % kürzer (Meta-Analyse); Cochrane 2024: −2,4 Tage, niedrige Evidenzsicherheit, mehr Nebenwirkungen. Vorbeugend nicht signifikant	**am besten**
Vitamin D	Atemwegsinfekte −8 % – nur bei täglich 400–1.000 IE; Stoßtherapie und über 2.000 IE wirkungslos	**leicht**
Vitamin C	regelmäßig: Erkältung bei Erwachsenen 8 % kürzer; erst bei Symptombeginn kein konsistenter Effekt	**leicht**
NAC	6 Monate vorbeugend: weniger Grippesymptome, nicht weniger Infektionen; akut nicht belegt	**unklar**
Echinacea	allenfalls schwacher Nutzen	**schwach**
Glutamin	kein Effekt auf die Immunfunktion	**keiner**
Curcumin	bessere Aufnahme, aber keine antivirale Wirkung beim Menschen; Fälle von Leberschäden bekannt	**keiner**
Omega-3 (3 g)	kein Infektschutz belegt; über 1 g/Tag 1,5-fach höheres Risiko für Vorhofflimmern	**keiner**
Nattokinase	baut das Spike-Protein nur im Labor ab; mit ASS Hirnblutung beschrieben (Fallbericht)	**keiner**

Was oft fehlt – und besser belegt ist

Einige einfache Mittel schneiden besser ab als viele teure Supplemente.

–24 %
Probiotika
Infekte der oberen Atemwege, Cochrane-Review mit 23 Studien

–36 %
Gurgeln mit Wasser
Atemwegsinfekte in einer randomisierten Studie aus Japan

Honig
gegen Husten
besser als Standardversorgung – erst ab einem Alter von 1 Jahr

Höchstmengen im Blick

Stoff	BfR: max. in NEM	Weitere Grenze
Zink	6,5 mg	EFSA-Obergrenze 25 mg; Arzneimittel darüber verschreibungspflichtig; Dauergabe: Kupfermangel
Vitamin D	800 IE	EFSA-Obergrenze 4.000 IE; Schadwirkungen ab 10.000 IE beschrieben
Vitamin C	250 mg	Einzelpräparate verdoppelten bei Männern das Nierenstein-Risiko

Niemals Zink-Nasenspray: Es kann zum Verlust des Riechvermögens führen.

So setzt du es um

1. Bei ersten Erkältungszeichen einige Tage Zink-Lutschtabletten nach Packungsbeilage – am besten Zinkacetat oder -gluconat ohne Zitronensäure.
2. Vitamin D im Winter täglich niedrig dosiert, wenn ein Mangel wahrscheinlich ist – keine Stoßtherapie.
3. Vitamin C lieber über Obst und Gemüse – hochdosiert erst bei Symptomen bringt es nichts.
4. Honig, Gurgeln, Probiotika als risikoarme Optionen. Nattokinase nie mit ASS oder Gerinnungshemmern.

MERKE Zink-Lutschtabletten verkürzen die Erkältung um rund 33 %. Vitamin D senkt Atemwegsinfekte um 8 % – nur mit täglich 400–1.000 IE. Probiotika senken Infekte der oberen Atemwege um 24 %.

Die Trainings-Ampel bei Infekt

Zum Ausschneiden und an den Kühlschrank hängen. Im Zweifel gilt immer: lieber pausieren.

ROT
kein Training

Fieber oder Allgemeinsymptome

Fieber, Gliederschmerzen, Husten, Abgeschlagenheit – oder du brauchst Antibiotika. Dann ist Training tabu, ohne Ausnahme: Belastung kann bei einem Virusinfekt den Herzmuskel schädigen.

GELB
langsam zurück

Nach dem Fieberende

Stufenweise steigern: zwei bis drei lockere Einheiten, bevor du wieder hart trainierst. Ein hartnäckiger Husten danach ist normal – eine Verschlechterung nicht.

GRÜN
locker bewegen

Nur oberhalb des Halses, kein Fieber

Reiner Schnupfen oder Halskratzen: leichte Aktivität ist möglich (Neck-Check – eine Expertenregel ohne Studienevidenz). Bei leichter Erkältung ohne Fieber änderte moderates Training den Verlauf nicht.

JEDERZEIT SOFORT STOPPEN BEI

- **Brustschmerz**
- **Herzstolpern**
- **ungewohnter Atemnot**
- **Leistungsknick**

… und ärztlich abklären lassen. Bei bestätigter Myokarditis: 3–6 Monate Pause, Rückkehr nur mit kardiologischer Freigabe.

Mythos-Check

Acht Winter- und Trainingsmythen – und was die Studienlage dazu sagt.

WIDERLEGT

„Dehnen beugt Verletzungen vor.“

In 25 Studien mit über 26.000 Personen: −4 %. Krafttraining: −68 %.

UNBELEGT

„Dehnen vor dem Training ist gefährlich.“

Kein Effekt auf Verletzungen, in keine Richtung. Unter 60 Sekunden kostet es nur etwa 1 % Kraft.

WIDERLEGT

„Ich habe eine Nebennierenschwäche.“

„Adrenal Fatigue“ ist keine anerkannte Diagnose. Speicheltests aus dem Internet sind dafür ungeeignet.

WIDERLEGT

„Vitamin D bringt +15–20 % Knochendichte.“

23 randomisierte Studien: +0,8 %, nur am Schenkelhals.

UNBELEGT

„K2 immer zusammen mit D3.“

Kein belegter Nutzen aus randomisierten Studien – weder für Knochen noch für Gefäße.

WIDERLEGT

„1 Liter pro 20 kg trinken, wenn du krank bist.“

Keine einzige Studie. Trink nach Durst, bei Fieber etwas mehr.

EHER UMGEKEHRT

„Penicilline No-Go, Makrolide mit Vorsicht.“

Penicilline: kein spezifisches Sportrisiko. Azithromycin: 2,9-fach höheres Herztod-Risiko während der Einnahme.

WIDERLEGT

„Mit Ruhe 7–10 Tage, ohne Ruhe 14–21.“

Keine Datengrundlage – 7–10 Tage sind einfach der natürliche Verlauf einer Erkältung.

Die Zahlen dieser Ausgabe

−68 %
Verletzungsrisiko durch Krafttraining

< 60 s
Dehnen pro Muskel kostet nur ~1 % Kraft

+21 %
Cortisol nach einer durchwachten Nacht

20 ng/ml
Vitamin D reicht laut DGE

4.000 IE
Vitamin-D-Höchstmenge der EFSA pro Tag

18 Tage
Husten nach Infekt im Mittel – normal

3–6 Mon.
Sportpause bei bestätigter Myokarditis

−33 %
Erkältungsdauer mit Zink-Lutschtabletten

Deine Winter-Checkliste

- [ ] Aufwärmen mit 2–3 steigenden Sätzen der ersten Übung
- [ ] 7–9 Stunden Schlaf zu festen Zeiten
- [ ] Cortison nie eigenmächtig absetzen
- [ ] Fieber = Trainingsverbot
- [ ] Zink-Lutschtabletten statt Nasenspray, nur einige Tage
- [ ] Verletzungsschutz durch Kraft- und Gleichgewichtstraining
- [ ] Deload-Wochen einplanen, nicht dauerhaft am Limit
- [ ] Oktober bis März 800–1.000 IE Vitamin D täglich
- [ ] Nach Infekt 2–3 lockere Einheiten vor hartem Training
- [ ] Warnzeichen am Herzen sofort ärztlich abklären

Ausgewählte Quellen

Aufwärmen & Dehnen
Behm DG et al. 2016 · Simic L et al. 2013 · McCrary JM et al. 2015 · Ribeiro B et al. 2021 · Lauersen JB et al. 2014 · Warneke K et al. 2024

Cortisol als Hormon
Bornstein SR et al. 2016 · Beuschlein F et al. 2024 (ESE) · Cadegiani FA, Kater CE 2016 · Lacroix A et al. 2015 · Leproult R et al. 1997 · Koncz A et al. 2021

Richtig krank sein
Heikkinen T, Järvinen A 2003 · Ebell MH et al. 2013 · Guppy MPB et al. 2011 (Cochrane) · Weidner TG et al. 1998

Cortisol im Training
Schakman O et al. 2008, 2013 · Pereira RM, Freire de Carvalho J 2011 · West DWD, Phillips SM 2012 · Lamon S et al. 2021

Vitamin D & K2
DGE 2016 · Demay MB et al. 2024 (Endocrine Society) · EFSA 2023 · BfR 2025 · Reid IR et al. 2014 · Jolliffe DA et al. 2021 · Manson JE et al. 2019 (VITAL)

Sport, Infekt & Herz · Supplemente
Gatmaitan BG et al. 1970 · Bohm P et al. 2016 · Bhatia RT et al. 2023 · Hemilä H 2017 · Nault D et al. 2024 (Cochrane)

Vollständige Quellenangaben findest du am Ende jedes Kapitels im Buch „iCoach.Me – Die Masterclass“ (Teile I, III, V, IX und XIII).

VORSCHAU · AUSGABE 03

Blutzucker, Schilddrüse und Regeneration

Blutzucker · Schilddrüse · Verletzungen & Regeneration · Testosteron

LIFESPAN OS
POWER TO THE PEOPLE

Impressum

iCoach.Me Magazin · Ausgabe 02 · November 2026
Herausgeber: iCoach.Me · [Anschrift / Kontakt]
Inhaltliche Grundlage: „iCoach.Me – Die Masterclass. Das Wissensbuch für Training, Ernährung und Gesundheit“, Stand Oktober 2026.

Wichtiger Hinweis

Dieses Magazin vermittelt Wissen, ersetzt aber keine ärztliche Diagnose, Therapie oder individuelle Beratung. Bei Fieber, Brustschmerz, Atemnot oder Herzstolpern lass dich ärztlich untersuchen. Medikamente wie Cortison oder Antibiotika nimmst und beendest du nur nach ärztlicher Vorgabe.